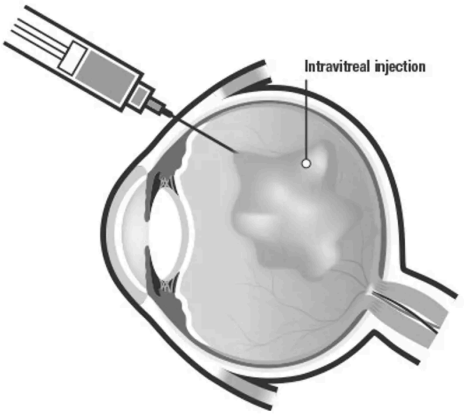
HagaZiekenhuis

Injecties in de oogbol (intravitreale injectie)

Bij een intravitreale injectie wordt een geneesmiddel rechtstreeks in het glasvocht (gelei-achtige vulling) van het oog gespoten. Het doel van deze injectie is om met een kleine hoeveelheid een maximaal effect van het geneesmiddel te verkrijgen.



Intravitreale injectie

Per patiënt wordt bekeken hoe vaak de injectie moet worden gegeven om tot het maximale resultaat te komen. Vervolgens wordt gekeken of dit maximale resultaat stabiel gehouden kan worden met een lagere frequentie van injecties. Daartoe zullen regelmatige tussentijdse controles gedaan worden, gecombineerd met een OCT- onderzoek (scan van het netvlies) Met dit onderzoek kunnen we goed vervolgen wat het effect is op het vocht in het netvlies. De meeste van deze aandoeningen zijn chronisch; u dient rekening te houden met een lang behandeltraject. Wel zijn na verloop van tijd vaak minder frequente injecties nodig.

Het geneesmiddel

De meest voorkomende aandoeningen waarbij injecties gegeven worden, zijn natte maculadegeneratie, diabetische retinopathie en vaatafsluitingen. De overeenkomst bij al deze aandoeningen is dat er lekkende bloedvaatjes kunnen ontstaan, met als gevolg vochtophoping in het netvlies. We beschikken over een aantal medicijnen welke de vaatlekkage vermindert en de prognose sterk verbetert. Zonder deze behandeling zou het gezichtsvermogen achteruitgaan, met de behandeling kunnen we stabilisering verkrijgen.

Bent u allergisch voor jodium? Meldt dit dan!

De procedure

De behandeling vindt plaats in een poliklinische behandelkamer.

1. Alvorens de injectie krijgt u verdovende oogdruppels.
2. Het oog en de huid worden gedesinfecteerd met jodium.

3. De behandelaar doet een spreider tussen de oogleden van het oog dat geprikt moet worden
4. Hierna wordt er nogmaals met verdunde jodium op het oog gedruppeld.
5. U wordt gevraagd een bepaalde kant op te kijken; probeert u een fixeerpunt te zoeken en hiernaar te blijven kijken tot de injectie gezet is.
6. De behandelaar zal na de injectie de spreider verwijderen. Eventueel wordt het oog nagespoeld of een gel achtergelaten op het oog.

De tijd die nodig is in de behandelkamer om het oog te injecteren, is ongeveer vijf minuten. De injectie zelf is vrijwel pijnloos. U kunt enige druk voelen bij de injectie. We adviseren u niet zelf auto te rijden na de injectie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het injecteren van het oog is het van belang dat er enkele voorzorgsmaatregelen genomen worden om de kans op infecties van het oog zo laag mogelijk te houden.

Om die reden verzoeken wij u op de dag van injectie:

- Geen oogmake-up te gebruiken
- De instructies voor en tijdens het injecteren nauwkeurig te volgen
- Na de injectie niet in het oog te wrijven

Mogelijke bijwerkingen van de injectie

De volgende bijwerkingen kunnen hinderlijk zijn, maar zijn alle voorbijgaand en onschuldig.

- Rood vlekje / bloedinkje: op het oogwit direct na de injectie. De injectie gaat door het witte gedeelte van het oog. Hierin bevinden zich vele kleine bloedvaatjes. Er kan daarom meteen na de injectie een klein bloedinkje in het oogwit te zien zijn. Dit is onschuldig. Een enkele keer kan de bloeding groter zijn waardoor een groot deel van het oogwit rood kleurt. Een kleine bloeding is binnen een paar dagen weggetrokken, een grotere kan wel een paar weken nodig hebben.
- Branderigheid: het oog kan na de injectie branderig aanvoelen. Deze klachten zijn binnen 24 uur hersteld.
- Zien van een balletje onder in het beeld: in het naaldje kunnen kleine luchtbelletjes verscholen zijn. Als een luchtbelletje in het oog komt, ziet u een bewegend balletje onder in uw beeld. Dit verdwijnt binnen een of twee dagen.

De volgende lokale complicaties kunnen optreden:

- Infectie (zeldzaam): bij minder dan 1 op de 2000 injecties. Als het oog binnen 1 week slechter gaat zien en/of roder wordt, pijnlijker of meer lichtschuw, dan moet u uw arts zo snel mogelijk waarschuwen. Vroegtijdige start van behandeling is van groot belang.
- Oogdrukverhoging: door frequente injecties kan de oogdruk wat oplopen. Dit speelt vooral een rol bij patiënten die al glaucoom hebben. Bij de controles zal de oogdruk daarom ook regelmatig gemeten worden.

- Netvliesloslating (zeer zeldzaam)
- Glasvochtbloeding (zeer zeldzaam)

Waar moet u op letten na uw intravitreale injectie?

- De eerste dagen na de injectie is een branderig zandkorrelgevoel normaal, u mag niet in het behandelde oog wrijven.
- De dag na de behandeling mag u weer make-up gebruiken.
- Uw contactlenzen mag u weer dragen als de ogen weer helemaal normaal aanvoelen, meestal is dat na 1 dag.
- De eerste drie dagen na de injectie mag u niet zwemmen of de sauna bezoeken.
- U kunt doordruppelen met eigen druppels.
- Niet vliegen gedurende 5 dagen na injectie.
- Door mogelijk verminderd zicht na injectie wordt geadviseerd niet dezelfde dag auto te rijden.

Wanneer moet u de oogarts bellen?

Neem contact op als u met het behandelende oog klachten heeft van:

- toename pijn
- plots minder gaat zien
- toename van roodheid
- flitsen en/of een groter wordende vlek ziet

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met deze geneesmiddelen?

- Bij zwangerschap
- Als u een vergroting en verzwakking van een bloedvatwand (aneurysma) of een scheur in een bloedvatwand (arteriële dissectie) heeft of heeft gehad.
- Het risico op het ontwikkelen van bloedstolsels in uw arteriën en/of aders (een type bloedvat) kan verhoogd zijn als u ouder bent dan 65 jaar, als u diabetes heeft, of als u in het verleden bloedstolsels in uw arteriën heeft gehad.

Contact

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

De polikliniek in Zoetermeer is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52 en van 16.30 tot 17.00 op (079) 346 26 26.

’s Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met het HagaZiekenhuis Den Haag, telefoonnummer: (070) 210 00 00. Vermeld hierbij dat u recent een injectie in het oog heeft gehad.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

543717072025